

ประสิทธิผลของการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลย

The Effectiveness of Development in Emergency Referral System of Nahaeo Hospital, Loei province.

ผู้วิจัย นางสาวพรทิพย์ เนตรแสงศรี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลย เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ (Action research) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ได้แก่ เลือกจากกลุ่มประชากรเป้าหมาย โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลย จำนวน 40 ราย และกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉิน (สีแดง และสีชมพู) ที่ได้รับการส่งต่อด้วยรถพยาบาลและมีบุคลากรทางการแพทย์นำส่งในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 ถึงเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 78 ราย

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยภาพรวมหลังการพัฒนาระบบมีระดับความพึงพอใจมากขึ้นก่อนการพัฒนาระบบ จากระดับความพึงพอใจมากเป็นระดับความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14 หลังการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลย ไม่พบอุบัติการณ์ผู้ป่วยเสียชีวิตขณะส่งต่อ อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมงหลังการ Admit หรือ Refer พบร้อยละ 1.28 (เกณฑ์ตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข กำหนดไม่เกินร้อยละ 12) และยังไม่พบการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse event) ซึ่งการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินให้เหมาะสมและการแก้ไขปัญหาของระบบการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินให้สอดคล้องกับปัญหาจะสามารถช่วยลดบรรเทาความรุนแรงของการเจ็บป่วยในผู้ป่วยฉุกเฉิน

คำสำคัญ ระบบส่งต่อ, ผู้ป่วยฉุกเฉิน, ประสิทธิภาพ, การพัฒนา

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในลำดับต้นๆของประเทศไทย เป็นภาวะวิกฤตหรือฉุกเฉินของแต่ละบุคคล หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม ทันทีที่ อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิต หรือเกิดความบกพร่องในการทำงานของอวัยวะสำคัญ รวมทั้งทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยรุนแรงขึ้นโดยไม่สมควร หรือเกิดการเสียชีวิตก่อนถึงวัยอันควร (มติชนออนไลน์, 2562)

ประเทศไทยออกแบบระบบบริการสุขภาพเพื่อให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีการกระจายหน่วยบริการต่างๆ ให้สอดคล้องทั้งในเชิงภูมิศาสตร์และระดับความเฉียบพลันของอาการของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม โดยมีการจัดระดับการส่งต่อผู้ป่วยทั้งฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพตามความจำเป็นได้อย่างเท่าเทียม มีความต่อเนื่องในการรับบริการสุขภาพ การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยที่ผ่านมายังพบประเด็นปัญหาต่างๆเป็นระยะโดยพบชัดเจนมากยิ่งขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรทั้งด้านบริหาร บริการ และระบบหลักประกันสุขภาพทั้งทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในระบบบริหารและบริการ จึงเกิดปัญหาสืบเนื่องมาและพบคุณภาพของระบบการดูแลรักษาพยาบาล เครือข่ายบริการสุขภาพที่ประกอบด้วยระดับชั้นต่างๆ ไม่เชื่อมโยงการส่งต่ออย่างติดขัดทั้งเรื่องการประสานงานระหว่างสถานพยาบาลต้นทางและสถานพยาบาลปลายทาง การติดต่อสื่อสาร ใช้เวลาในการติดต่อนาน รถพยาบาลและพนักงานขับรถไม่พร้อม เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ขาดแคลนอัตราากำลัง ด้านการจัดการระบบข้อมูล การส่งต่อผู้ป่วยยังมีความไม่ชัดเจนก่อให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติ มีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน มีปัญหาในการปฏิบัติ ซึ่งความขัดแย้งบางประเด็นก็อาจทำให้โอกาสเสี่ยงในการเกิดความผิดพลาดสูงขึ้น เป็นสาเหตุทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นได้ทำให้มีการร้องเรียนและฟ้องร้องมากขึ้นต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนให้มีการการจัดทาแนวทางพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบบริหารและบริการสุขภาพ (Service Plan) โดยแนวทางพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เกิดความเป็นธรรมและความต่อเนื่องในการรับบริการในสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าและการส่งผู้ป่วยกลับไปรับบริการยังสถานบริการระดับต้น จนผู้ป่วยหายจากการเจ็บป่วย ซึ่งแนวทางการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยดังกล่าวเป็นการวางแนวทางพัฒนาในเชิงระบบที่นำปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกันทั้งในระดับกระทรวง เครือข่ายเขต โดยมีเป้าหมายคือ “ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่เหมาะสม ปลอดภัย” (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน, 2557)

โรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลย เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด F3 เต็มให้บริการผู้ป่วยใน จำนวน 28 เตียง ระยะห่างจากตัวเมืองจังหวัดเลย ระยะทาง 116 กิโลเมตร มีบุคลากรทั้งหมด 100 คน ประกอบด้วยแพทย์ประจำ จำนวน 1 คน (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล) และแพทย์ใช้ทุนมาช่วยให้บริการหมุนเวียนบางครั้ง จำนวน 1 คน ทันตแพทย์ จำนวน 2 คน เภสัชกร จำนวน 3 คน พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 25 คน (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาล จำนวน 22 คน และปฏิบัติงาน PCU จำนวน 3 คน) และบุคลากรตำแหน่งอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา จำนวน 67 คน ปริมาณการให้บริการ จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ ปีงบประมาณ 2562 – 2565 จำนวน 40,614, 38,829, 42,018 และ 55,665 ครั้ง ตามลำดับ จำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยในทั้งหมดในปีงบประมาณ 2562 – 2565 จำนวน 1,524, 1,114, 1,190 และ 7,482 ราย

ตามลำดับ สถิติผู้ป่วยได้รับการส่งต่อเพื่อไปรักษาตัวโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า ปีงบประมาณ 2562 – 2565 จำนวน 1,242, 1,356, 1,126 และ 1,047 ราย ตามลำดับ ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน Level1 สีแดง และ Level 2 สีชมพู ได้รับการส่งต่อด่วนโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์นำส่ง ปีงบประมาณ 2562 – 2565 จำนวน 325, 384, 227 และ 190 ราย ปัญหาอุปสรรคในการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน Level1 สีแดง และ Level 2 สีชมพู ปีงบประมาณ 2562 – 2565 จำนวน 25 (ร้อยละ 7.69), 31 (ร้อยละ 8.07), 34 (ร้อยละ 8.83) และ 10 (ร้อยละ 5.26) ครั้ง ตามลำดับ โดยมีอุบัติการณ์ผู้ป่วยเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น ในขณะที่ส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน Level1 สีแดง และ Level 2 สีชมพู ปีงบประมาณ 2562 – 2565 จำนวน 1 (ร้อยละ 0.30), 2 (ร้อยละ 0.52), 1 (ร้อยละ 0.44) และ 1 (ร้อยละ 0.53) ราย ตามลำดับ (กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลนาแห้ว, 2565) โรงพยาบาลนาแห้วมีข้อจำกัดที่จำเป็นต้องส่งต่อ (Refer Out) ผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า เช่น เกินศักยภาพในการบริการ ด้านการวินิจฉัย/ รักษา การขาดเครื่องมือทางการแพทย์ ขาดบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือการทำหัตถการที่มีความซับซ้อนที่เกินความสามารถทำได้ เฉพาะในโรงพยาบาลแม่ข่าย เป็นต้น ในผู้ป่วยช่องทางด่วนพิเศษ ได้แก่ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน และภาวะช็อคจากติดเชื้อ เป็นต้น ซึ่งระยะทางส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลนาแห้วไปยังโรงพยาบาลเลย ระยะทาง 116 กิโลเมตร ระยะทางค่อนข้างไกล อาจเกิดอันตรายกับผู้ป่วยขณะส่งต่อได้ ซึ่งปัญหาอุปสรรคในการส่งต่อของโรงพยาบาลนาแห้วมีดังนี้ 1. การประเมินก่อน ระหว่าง และหลังส่งต่อไม่เหมาะสม 2. ขาดการสื่อสาร และการสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ 3. การเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในระหว่างส่งต่อไม่เหมาะสม ซึ่งการส่งต่อผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยขณะส่งต่อ อีกทั้งจำเป็นต้องมีรถพยาบาลที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่มีคุณภาพพร้อมใช้นำส่ง

โรงพยาบาลนาแห้วมีการพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซึ่งทีมผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบส่งต่อของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพและปลอดภัย นอกจากนั้นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ทุกโรงพยาบาลมีการพัฒนาระบบบริการตามแผนบริการ (Service plan) ด้านผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และการส่งต่อต้องมีการประเมินระบบบริการของโรงพยาบาลด้วยมาตรฐาน Emergency Care System (ECS) ทุกปี ซึ่งในปี 2562 – 2565 โรงพยาบาลนาแห้ว ได้มีผลการประเมินมาตรฐานงานด้วยระบบ ECS คิดเป็นร้อยละ 45.32, 48.21, 64.17 และ 65.32 ตามลำดับ ผู้วิจัยในฐานะหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินเลยนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลนาแห้ว จึงสนใจที่จะพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลนาแห้ว เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลนาแห้ว ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย และญาติ

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลย

สมมติฐานการวิจัย

หลังการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลย แตกต่างจากก่อนการพัฒนา
พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลย

ขอบเขตการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลย ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้

1.5.1 ขอบเขตด้านประชากร คือ บุคลากรโรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลย จำนวนทั้งหมด 100 คน

1.5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ การศึกษามุ่งเน้นศึกษาเรื่องผลของการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย
ฉุกเฉินของโรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลย

1.5.3 ขอบเขตด้านเวลา ศึกษากลุ่มตัวอย่างในช่วง จำนวน 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31
ตุลาคม 2565

รูปแบบการวิจัย

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้รูปแบบการศึกษาเชิงปฏิบัติการ (Action research) เพื่อศึกษาผลของการ
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลย

ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ บุคลากรโรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลย จำนวนทั้งหมด 100 คน
และกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉิน (สีแดง และสีชมพู) ที่ได้รับการส่งต่อด้วยรถพยาบาลและมีบุคลากรทางการแพทย์นำส่ง
ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 ถึง เดือนตุลาคม 2565

เกณฑ์คัดเข้า

1) เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลย และ
เป็นกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉิน (สีแดง และสีชมพู) ที่ได้รับการส่งต่อด้วยรถพยาบาลและมีบุคลากรทางการแพทย์นำส่ง
ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 ถึง เดือนตุลาคม 2565

2) มีประสบการณ์ในปฏิบัติงานในระบบส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลยไม่
น้อยกว่า 1 เดือน

3) ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัยและลงชื่อในแบบแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

เกณฑ์คัดออก

1) กลุ่มตัวอย่างไม่สะดวกในการดำเนินการวิจัยจนสิ้นสุดทุกการวิจัยได้

2) เป็นบุคลากรที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลนาแห้ว

กลุ่มตัวอย่าง

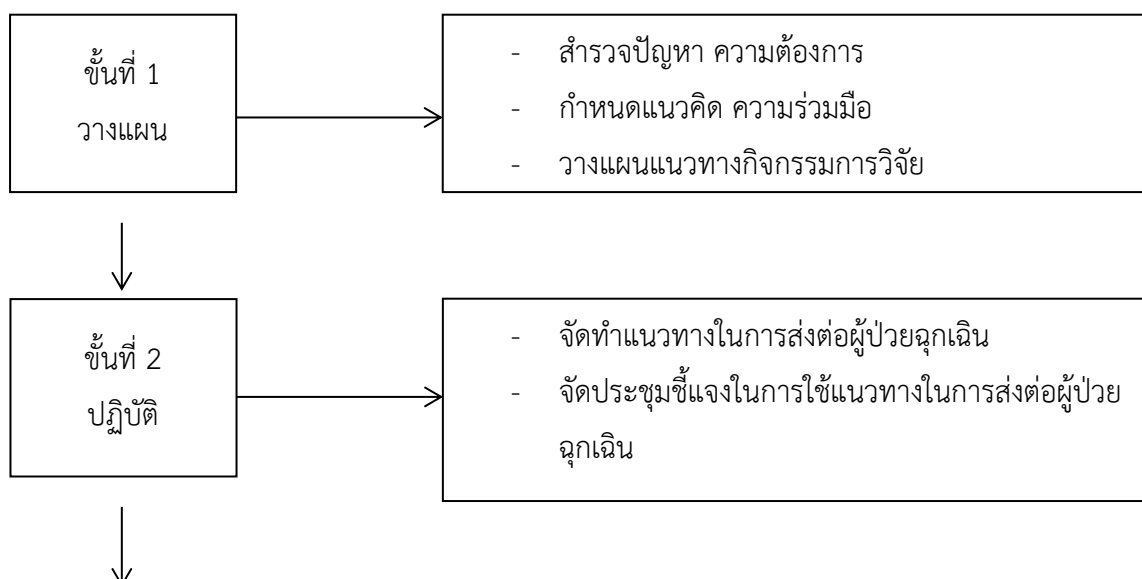
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 คน ได้แก่ แพทย์ จำนวน 2 คน พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 20 คน เวชกิจฉุกเฉิน จำนวน 1 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 12 คน และพนักงานขับรถพยาบาล จำนวน 5 คน และกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉิน (สีแดง และสีชมพู) ที่ได้รับการส่งต่อด้วยรถพยาบาลและมีบุคลากรทางการแพทย์นำส่งในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 ถึง เดือนตุลาคม 2565 จำนวน 78 ราย โดยผู้วิจัยได้เลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์คัดเข้าและเกณฑ์คัดออก

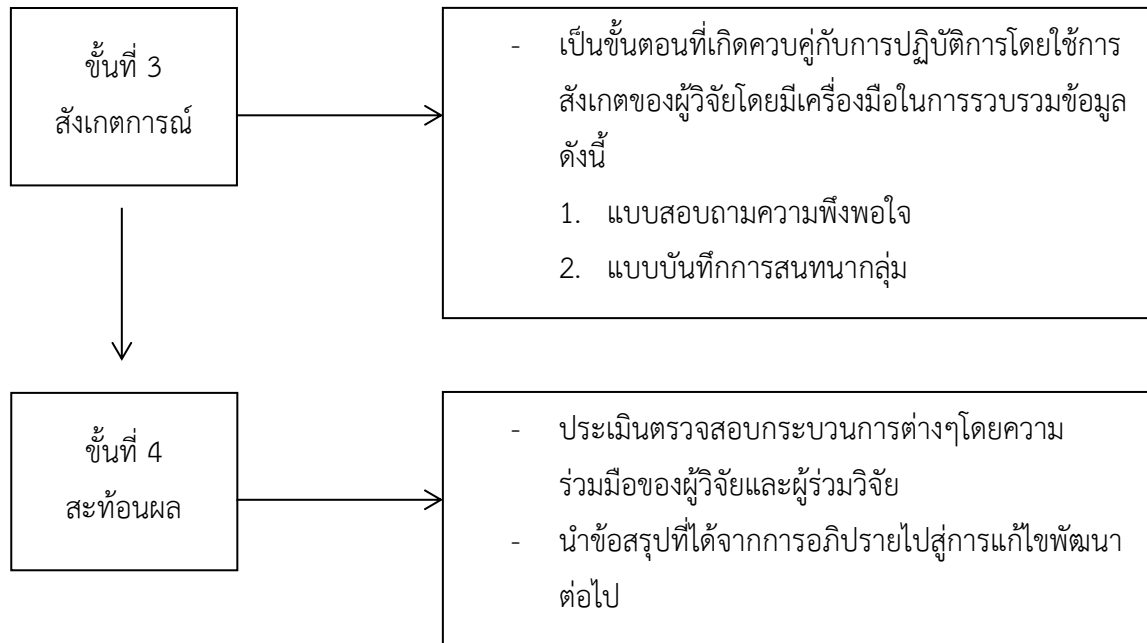
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

ความพึงพอใจต่อระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยดัดแปลงข้อคำถามจากการศึกษาการพัฒนากระบวนการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินแบบครบวงจร โรงพยาบาลนครพนม ของทิพย์วิภา สังข์อินทร์ และคณะ มีการวัดระดับความพึงพอใจของปัจจัยต่าง ๆ ใช้มาตรา ลิเคิร์ต 5 ระดับ ซึ่งลักษณะคำถามมีคำตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ ความพึงพอใจน้อยที่สุด ความพึงพอใจน้อย ความพึงพอใจปานกลาง ความพึงพอใจมาก ความพึงพอใจมากที่สุด (ฤทธิ์ไกร ไชยงาม, 2562) และข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลนาแห้ว ดังนั้น อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง หลัง Admit หรือ Refer, จำนวนครั้งการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (adverse event) และอุบัติการณ์ผู้ป่วยเสียชีวิตขณะส่ง

วิธีการศึกษา

การพัฒนากระบวนการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลย ในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช้กระบวนการ PAOR ตามแนวคิดของเคมมิส และแมกทากาท (Kemmis & Mc Taggart, 1990) เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวางแผน (Planing) 2) ขั้นปฏิบัติ (Action) 3) ขั้นสังเกตการณ์ (Observation) 4) ขั้นสะท้อนผล (Reflection) เพื่อดำเนินการตามโครงการวิจัย





การวิเคราะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ หลังการเข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่องประสิทธิผลของการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลนาแห้ว โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าสูงสุด ต่ำสุด
3. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง หลัง Admit หรือ Refer โดยตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดคือน้อยกว่าร้อยละ 12 ซึ่งมีสูตรคำนวณตัวชี้วัด ดังนี้ (จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (ทั้ง trauma และ non-trauma) ที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง/จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (ทั้ง trauma และ non-trauma) ทั้งหมด) $\times 100$ (กระทรวงสาธารณสุข, 2565)
5. จำนวนครั้งการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (adverse event) คือ อุบัติการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย ครอบคลุมถึงการเกิดภาวะแทรกซ้อน การบาดเจ็บ ความทุกข์ทรมาน ความพิการ และการเสียชีวิต โดยหาค่าร้อยละ
6. อุบัติการณ์ผู้ป่วยเสียชีวิตขณะส่งต่อ โดยแสดงข้อมูลเป็นจำนวน โดยตัวชี้วัดโรงพยาบาลนาแห้ว กำหนดคือ ต้องไม่มีการเกิดอุบัติเหตุผู้ป่วยเสียชีวิตขณะส่งต่อ

ผลการวิจัย

จากการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลย พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมหลังการพัฒนาระบบมีระดับความพึงพอใจมากขึ้นก่อนการพัฒนาระบบจากระดับความพึงพอใจมากเป็นระดับความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14 โดยก่อนการพัฒนาระบบได้มีปัญหาดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นขณะออกเหตุ 2. เจ้าหน้าที่บางท่านไม่รู้ที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆภายในรถ 3. การส่งต่อล่าช้าเนื่องจาก

เอกสาร 4. ใช้เครื่องช่วยหายใจไม่คล่อง 5. การรับแจ้งเหตุข้อมูลไม่เพียงพอ 6. ข้อมูลคนไข้ว่าเร่งด่วนหรือปกติ คนไข้เป็นโรคหรือโรคอื่นๆที่เสี่ยงต่อการติดต่อ 7. ไม่มี FR 8. รถไม่รองรับคนไข้ที่ส่งต่อแล้วไม่ได้นอนค้างคืน และได้ขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบ ดังนี้ 1. ควรมีการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นขณะออกเหตุแก่ พนักงานใหม่ 2. เจ้าหน้าที่ประจำรถควรมีการเช็คอุปกรณ์และที่เก็บ 3. เจ้าหน้าที่ที่ออกเหตุควรปฐมพยาบาลจนจุดเกิดเหตุตามลำดับก่อนนำขึ้นรถ 4. ควรมีการเวียนเช็คอุปกรณ์ให้ครบทุกคน 5. ควรมีการอบรม การใช้เครื่องช่วยหายใจ 3 เดือนต่อครั้ง 7. เมื่อได้รับการแจ้งเหตุควรสอบถามข้อมูลผู้ป่วยละเอียด 8. ควรมี การสอนใช้เครื่อง ventilater บนรถ 9. ควรจัดเวทียแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทราบปัญหาของเครือข่ายงานส่งต่อและ 10. รถควรรองรับคนไข้ที่ส่งต่อแล้วไม่ได้นอนค้างคืน

ผลของการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลย พบว่า ในปีงบประมาณ 2565 ก่อนการพัฒนามีผู้ป่วยฉุกเฉินส่งต่อด้วยรถพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 165 ราย พบ อุบัติการณ์ผู้ป่วยเสียชีวิตขณะส่งต่อ จำนวน 1 ราย อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง หลัง Admit หรือ Refer คิดเป็นร้อยละ 0.60 พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse event) จำนวน 1 ครั้ง หลังการ พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลย มีผู้ป่วยฉุกเฉินที่ส่งต่อด้วยรถพยาบาลและ บุคลากรทางการแพทย์นำส่ง จำนวน 78 ราย ไม่พบอุบัติการณ์ผู้ป่วยเสียชีวิตขณะส่งต่อ พบผู้ป่วยฉุกเฉิน เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง หลังการส่งต่อ จำนวน 1 ราย ที่ ICU โรงพยาบาลเลย อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย ภายใน 24 ชั่วโมง หลัง Refer คิดเป็นร้อยละ 1.28 (ซึ่งผู้ป่วยรายนี้มีภาวะหัวใจหยุดเต้น (OHCA) ก่อนมาถึง โรงพยาบาลนาแห้ว) และหลังการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินไม่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse event)

การอภิปรายผล

หลังการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลย พบผู้ป่วยเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง หลัง Admit หรือ Refer จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.28 โดยตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดคือน้อยกว่าร้อยละ 12 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ค่าน้อยกว่าตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข โดยสาเหตุที่พบ ผู้ป่วยเสียชีวิตเนื่องมาจากผู้ป่วยมีภาวะหัวใจหยุดเต้น (OHCA) ก่อนมาถึงโรงพยาบาลนาแห้ว และได้รับการส่ง ต่อจากโรงพยาบาลนาแห้วไปยังโรงพยาบาลเลย แล้วเสียชีวิตที่โรงพยาบาลปลายทางหลังการส่งต่ออยู่ใน ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (ที่ ICU โรงพยาบาลเลย) ไม่ได้เสียชีวิตเนื่องจากระบบการส่งต่อแต่เสียชีวิตด้วยภาวะ โรคเดิมของผู้ป่วย (CHF) โดยระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ควรมีการพัฒนาดังนี้ มีคณะทำงานเพื่อส่งเสริมให้ บุคลากรการทำงานตามมาตรฐาน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานจริงให้เป็นไปตาม มาตรฐาน เพื่อเป็นการทบทวนองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติก่อนปฏิบัติงานจริง และยังต้องมีการซ่อมแผนในการ ส่งต่อผู้ป่วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของทิพย์วิภา สังข์อินทร์ และคณะ (2563) ศึกษาการพัฒนาระบบส่งต่อ ผู้ป่วยฉุกเฉินแบบครบวงจร โรงพยาบาลนครพนม โดยระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีมาตรฐานในการดำเนินงาน สามารถช่วยลดบรรเทาความรุนแรงของการเจ็บป่วยในผู้ป่วยฉุกเฉินได้ รวมถึงต้องมีการเตรียมความพร้อมใน

ทุกๆด้าน ได้แก่ การรับแจ้งเหตุ การประสานงานทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน รถพยาบาล อุปกรณ์ ผู้ปฏิบัติงาน เวชภัณฑ์ ผู้ป่วย และญาติ

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

1. ผู้วิจัยควรดำเนินงานวิจัยนี้โดยปรับปรุงแนวทางให้เหมาะสมกับพื้นที่และบริบท
2. ผู้วิจัยควรดำเนินงานวิจัยเพิ่มขึ้นจาก 6 เดือน เป็น 1 ปีงบประมาณ เพื่อให้สามารถที่จะเก็บข้อมูลได้อย่างครอบคลุม
3. ผู้วิจัยควรดำเนินการศึกษาวิจัยให้ครอบคลุมในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว และสีเหลือง ที่ได้รับการนำส่งด้วยรถพยาบาลอย่างเดียวเพิ่มเติม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบส่งต่อการดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมมากขึ้น
4. ผู้วิจัยควรดำเนินการศึกษาวิจัยค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการส่งต่อผู้ป่วยเพิ่มเติม เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา และพัฒนาให้ครอบคลุมมากขึ้น

เอกสารอ้างอิง

1. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ. คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน และจัดลำดับการบริการ ณ ห้องฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ที่ กพฉ. กำหนด. กรุงเทพฯ: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ; 2556.
2. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ. การปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินระหว่างสถานพยาบาล. กรุงเทพฯ: บริษัท อัลติเมท พรินติ้ง จำกัด; 2557.
3. Kemmis, S and , McTagart. (1990). The Action Research Planner. Geelong : Deakin University Press.
4. ทิพย์วิภา สังข์ชินทร์ และคณะ. การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินแบบครบวงจร โรงพยาบาลนครพนม. วารสารโรงพยาบาลนครพนม 2563;8(2):104-94.
5. วาสีทธิ์ นงนุช และคณะ. การพัฒนาคุณภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินระหว่างสถานพยาบาล โรงพยาบาลเชียงใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560;10(2):57-49.
6. นงลักษณ์ ชัดแก้ว. ผลของแนวปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยผู้ป่วยโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่. วารสารโรงพยาบาลแพร่ 2561;26(1):22-8.
7. ฤทธิไกร ไชยงาม. มาตรวัดเจตคติแบบลิเคิร์ต (Likert rating scales) [อินเทอร์เน็ต]. 2562 [เข้าถึงเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565]. เข้าถึงได้จาก: <https://www.gotoknow.org/posts/659229>
8. กระทรวงสาธารณสุข. แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) พ.ศ. 2555-2559. นนทบุรี: สำนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข; 2555.
9. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน. การปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินระหว่างสถานพยาบาล. Interfacility patient Transfer. นนทบุรี: อัลติเมท พรินติ้ง; 2557.
10. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน. แผนกลยุทธ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561- 2580). นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข; 2560.
11. มติชนออนไลน์. คนไทยได้อะไรจากการปฏิรูประบบการแพทย์ฉุกเฉิน [อินเทอร์เน็ต]. 2562 [เข้าถึงเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565]. เข้าถึงได้จาก: <https://www.matichon.co.th/publicize/>
12. กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลนาแห้ว. ข้อมูลการส่งต่อโรงพยาบาลนาแห้ว. 2565 [เอกสารไม่ได้ตีพิมพ์].
13. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) . เป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย ของประเทศไทย พ.ศ. 2561. กรุงเทพมหานคร: เฟมัส แอนด์ ซัคเซสฟูล; 2561.